

TEMA 1.5 • PEDIATRÍA

Microcefalia, Macrocefalia y Cefalea en Niños

PERFIL EUNACOM 2.01.1.079

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Microcefalia, Macrocefalia y Cefalea en Niños

1. Microcefalia

Definición: Perímetro craneal (PC) < -2 desviaciones estándar (DE) del promedio para sexo y edad. Algunos definen microcefalia severa como < -3 DE.

- **Causas:**
- **TORCH** (más frecuente): citomegalovirus, toxoplasma, virus Zika
- Genopatías: síndrome de Down, otras
- Noxas intrauterinas: **síndrome alcohólico fetal**, radiación, medicamentos teratogénicos
- **Riesgo asociado:** Discapacidad cognitiva/retraso mental:
- ~70% con corte < -2 DE
- ~85% con corte < -3 DE

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

La microcefalia es importante porque se asocia a **daño cerebral y discapacidad cognitiva** en la gran mayoría de los casos.

- **Diagnóstico:**
- Clínico: medir el PC del niño
- Complementar con **neuroimagen** (ecografía cerebral, TAC, RM) para buscar la causa
- **Tratamiento:**
- Enfoque **multidisciplinario** (discapacidad cognitiva)
- Tratar causa subyacente si es tratable (ej. infección)

2. Macrocefalia

Definición: PC $> +2$ DE del promedio para sexo y edad.

- **Causas:**
- **Constitucional/familiar** (90%): la causa más frecuente. Niño con cabeza grande pero papás también cabezones → normal
- **Hidrocefalia:** acumulación de LCR → la causa más importante a descartar
- **Signos de alarma (sospechar hidrocefalia u otra causa patológica):**
- Examen neurológico alterado (hipotonía, espasticidad, convulsiones)
- Macrocefalia **progresiva** (va aumentando en DE)
- **Signo de la puesta de sol:** ojos "empujados" hacia abajo, con esclerótica visible en la parte superior → signo clásico de **hipertensión endocraneana / hidrocefalia**
- **Diagnóstico:**
- Si no hay signos de alarma y es familiar → solo observación, **sin neuroimagen**
- Si hay signos de alarma → **neuroimagen** (ecografía transfontanelar, TAC)
- Diagnóstico antenatal: ecografía obstétrica

Tratamiento: Según la causa. Si es constitucional → observación.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Regla práctica: si el niño tiene la cabeza grande, mide la cabeza de los papás. Si también son macrocéfalos → causa constitucional, tranquilizar a la familia.

3. Cefalea en Niños

Principio fundamental: El enfrentamiento de la cefalea en niños es **idéntico al del adulto**.

- **Conducta:**
- Anamnesis completa + examen físico (incluir fondo de ojo, signos meníngeos, examen neurológico)
- **Sin signos de alarma:** Manejo sintomático (AINEs, paracetamol). Tratar el tipo de cefalea (migraña, tensional, etc.)
- **Con signos de alarma** (signos meníngeos, focalidad neurológica, alteración de conciencia, edema de papila) → **Neuroimagen** para identificar causa → tratar según hallazgo

NOTA CLÍNICA

Si se sospecha meningitis → punción lumbar después de la neuroimagen (o directamente si no hay signos de HEC).

Tipos de cefalea en niños: Igual que adultos: migraña, cefalea tensional, cefalea en racimos. El tratamiento es el mismo.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Niño de 8 años consulta por cefaleas recurrentes de 6 meses. Describe dolor pulsátil hemicraneal derecho, náuseas y fotofobia, que dura 4-6 horas. Cede con ibuprofeno. Examen neurológico normal. ¿Cuál es el diagnóstico?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Microcefalia, Macrocefalia y Cefalea en Niños. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Microcefalia: PC < -2 DS para edad/sexo; causas: TORCH (CMV, Toxoplasma), genéticas, alcohol prenatal
- Macrocefalia: PC $> +2$ DS; causa más frecuente hidrocefalia; también megalencefalia familiar benigna
- Hidrocefalia: dilatación ventricular en TC; tratamiento derivación ventriculoperitoneal
- Migraña pediátrica: unilateral o bilateral, pulsátil, con/sin aura; ibuprofeno 1ª línea, sumatriptán si falla
- Cefalea tensional: bilateral, opresiva no pulsátil, no vómitos, no agravada por actividad; analgésicos simples
- Señales de alarma en cefalea: nocturna, empeora acostado, edema papilar, déficit neurológico → neuroimagen urgente

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (MICROCEFALIA, MACROCEFALIA Y CEFALEA EN NIÑOS)

PREGUNTA 1

Niño de 8 años consulta por cefaleas recurrentes de 6 meses. Describe dolor pulsátil hemicraneal derecho, náuseas y fotofobia, que dura 4-6 horas. Cede con ibuprofeno. Examen neurológico normal. ¿Cuál es el diagnóstico?

- ☐ A) Cefalea tensional episódica
- ☐ B) Migraña sin aura
- ☐ C) Neuralgia del trigémino
- ☐ D) Hipertensión endocraneana
- ☐ E) Sinusitis frontal

PREGUNTA 2

Lactante de 6 meses con perímetro cefálico en P98 (+2.5 DS). Fontanela anterior abombada, suturas diástasis, ojos en sol poniente. Desarrollo psicomotor normal hasta ahora. ¿Cuál es la conducta?

- ☐ A) Tranquilizar a los padres: macrocefalia familiar benigna
- ☐ B) Ecografía transfontanelar o TC cerebral para descartar hidrocefalia
- ☐ C) Punción lumbar diagnóstica
- ☐ D) Fondo de ojo y control en 1 mes
- ☐ E) Resonancia magnética con sedación en forma programada

PREGUNTA 3

Niña de 10 años presenta cefalea intensa que la despierta a las 3 AM, asociada a vómitos en proyectil. Ha tenido 3 episodios similares en las últimas 2 semanas. Sin fiebre. ¿Qué conducta es prioritaria?

- ☐ A) Diagnosticar migraña y prescribir triptanes
- ☐ B) Solicitar TC o RM cerebral urgente
- ☐ C) Analgésicos orales y control en 1 semana
- ☐ D) EEG para descartar epilepsia
- ☐ E) Punción lumbar para medir presión de apertura

RESUMEN: MICROCEFALIA, MACROCEFALIA Y CEFALEA EN NIÑOS

Definición: Perímetro craneal (PC) < -2 desviaciones estándar (DE) del promedio para sexo y edad. Algunos definen microcefalia severa como < -3 DE. **La microcefalia es importante porque se asocia a daño cerebral y discapacidad cognitiva en la gran mayoría de los casos.** **Regla práctica:** si el niño tiene la cabeza grande, mide la cabeza de los papás. Si también son macrocéfalos → causa constitucional, tranquilizar a la familia.